

Ruptura uterina

1. Introducción y relevancia clínica

La **ruptura uterina** se define como la **solución de continuidad total o parcial de la pared uterina**, que permite la **comunicación entre la cavidad uterina y la cavidad peritoneal**, con o sin salida del feto al abdomen.

Es una de las **emergencias obstétricas más graves**, y constituye una **causa importante de hemorragia, shock y muerte materna y fetal**.

Su frecuencia ha disminuido gracias al manejo quirúrgico seguro y control del parto, pero sigue siendo **alta en pacientes con cesárea previa o trabajo de parto prolongado e inadecuadamente controlado**.

□ Pregunta EUNACOM típica:

“Mujer con cesárea anterior en trabajo de parto presenta dolor súbito, pérdida de las contracciones y bradicardia fetal. Al tacto, la presentación asciende. Diagnóstico: ruptura uterina.”

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El útero en trabajo de parto está sometido a una gran presión y tracción. Si existe un **área debilitada de la pared uterina** (por cicatriz quirúrgica, traumatismo o sobredistensión), esta puede **ceder ante la contracción uterina**, produciendo ruptura.

Mecanismos principales

- **Cicatriz uterina previa (80–90%)**: especialmente de cesárea clásica (vertical corporal) o histerotomía.
- **Sobre distensión uterina**: embarazo múltiple, polihidroamnios, macrosomía.
- **Trabajo de parto obstructivo**: desproporción céfalo-pélvica, parto instrumental forzado.
- **Uso inadecuado de uterotónicos (oxitocina o misoprostol)**.

Consecuencias

- Hemorragia intraabdominal masiva.
- Extravasación del feto y placenta al peritoneo.
- Shock hipovolémico materno.
- Hipoxia y muerte fetal rápida.

3. Clasificación

Tipo	Descripción	Ejemplo
Ruptura completa	Solución de continuidad de todas las capas (endometrio, miometrio y serosa).	Cesárea previa corporal o T invertida.
Ruptura incompleta o dehiscencia	La serosa permanece intacta.	Cicatriz segmentaria baja.
Espontánea	Sin manipulación.	Trabajo de parto prolongado.
Traumática	Por instrumentación o maniobras obstétricas.	Fórceps, versión interna.

□ EUNACOM considera “ruptura uterina” al cuadro completo con comunicación peritoneal y repercusión materno-fetal.

4. Factores de riesgo

Factores uterinos	Obstétricos / iatrogénicos	Fetales
-------------------	----------------------------	---------

Cesárea previa, miomectomía, perforación uterina	Uso excesivo de oxitocina o prostaglandinas	Macrosomía
Malformaciones uterinas	Trabajo de parto prolongado o distócico	Embarazo múltiple
Placenta percreta / increta	Parto instrumental, maniobras agresivas	Polihidroamnios
Edad materna avanzada	Inducción en útero cicatricial	—

□ El **mayor riesgo**: útero con **cesárea corporal o en T**, especialmente si el trabajo de parto es inducido.

5. Manifestaciones clínicas

La **ruptura uterina completa** suele ser **súbita y dramática**, mientras que la dehiscencia puede pasar inadvertida.

A. Signos y síntomas maternos

- Dolor abdominal **intenso y súbito**, a menudo descrito como “desgarro”.
- **Cese de las contracciones** uterinas.
- **Sangrado vaginal variable** (a veces escaso si hemorragia intraperitoneal).
- **Shock hipovolémico**: palidez, taquicardia, hipotensión.
- **Fondo uterino mal definido o irregular**.
- **Feto palpable fácilmente a través del abdomen** (por salida al peritoneo).

B. Signos fetales

- **Bradicardia fetal súbita o pérdida de latidos**.
- **Pérdida de la estación fetal** (presentación asciende en canal del parto).

- Muerte fetal si no se actúa en minutos.

□ Triada clásica EUNACOM:

Dolor súbito + pérdida de contracciones + bradicardia fetal → ruptura uterina.

6. Diagnóstico

Clínico (principal)

- Antecedente de cesárea o cirugía uterina + signos clínicos agudos.
- Diagnóstico inmediato basado en la sospecha clínica.

Apoyo instrumental

- **Ecografía:** puede mostrar feto en cavidad abdominal o líquido libre (hemoperitoneo).
- **Exploración quirúrgica:** confirma diagnóstico (laparotomía).

El diagnóstico debe ser **presuntivo y rápido**: no se debe demorar por exámenes.

7. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencias clave
Desprendimiento prematuro de placenta (DPPNI)	Dolor + sangrado, útero hipertónico, sin pérdida de estación fetal.
Embolia de líquido amniótico	Colapso y CID sin dolor ni pérdida de estación.
Rotura de ligamento redondo o hematoma uterino	Dolor localizado sin compromiso fetal severo.

8. Manejo inmediato

La ruptura uterina es una **emergencia quirúrgica absoluta**.

A. Reanimación y estabilización

1. **ABC de reanimación materna:**
 - Oxígeno 100%.
 - Vías venosas gruesas (2 líneas 14–16 G).
 - Reposición rápida con cristaloides y sangre cruzada.
2. **Monitoreo hemodinámico continuo.**
3. **Notificar equipo quirúrgico y neonatología.**

B. Resolución quirúrgica

- **Laparotomía exploradora inmediata.**
 - Extraer feto y placenta.
 - Control de hemorragia.
 - Evaluar viabilidad de reparación uterina.

C. Conducta quirúrgica específica

Tipo de lesión	Conducta
Ruptura pequeña, segmento inferior, hemostasia posible	Reparación uterina (sutura en 2 planos).
Ruptura extensa, sangrado incontrolable, multiparidad o cicatriz antigua	Histerectomía subtotal o total.

☐ En Chile, la conducta depende de la **estabilidad materna** y **deseo reproductivo futuro**.

D. Manejo del feto

- Extraer de inmediato si con vida (cesárea o laparotomía).
 - Reanimación neonatal avanzada según protocolo.
-

9. Manejo en el posoperatorio

- Transfusión según pérdidas.
 - Control de diuresis y signos de shock.
 - Antibióticos profilácticos.
 - Seguimiento psicológico y asesoramiento sobre anticoncepción definitiva si hubo histerectomía.
 - Control de cicatriz uterina en futuros embarazos (riesgo de recurrencia $\approx$ 5–9%).
-

10. Prevención

Situación	Medida preventiva
Cesárea previa	Evitar inducción con prostaglandinas o trabajo prolongado.
Parto vaginal después de cesárea (PVDC)	Aceptable solo con cesárea segmentaria baja y vigilancia continua.
Uso de oxitocina	Dosificación cuidadosa y monitorización fetal.
Distocia o desproporción	Diagnóstico precoz y cesárea oportuna.
☐ La cesárea corporal o en T invertida contraindica el PVDC.	

11. Complicaciones

Maternas

- Hemorragia masiva y shock hipovolémico.
- Coagulación intravascular diseminada (CID).
- Histerectomía de urgencia.
- Muerte materna (10–25%).

Fetales

- Hipoxia o muerte fetal (50–75%).
 - Prematurez en rupturas espontáneas tempranas.
-

12. Pronóstico

Depende del tiempo de diagnóstico y del volumen de sangrado.

- **Mortalidad materna:** 5–25%.
- **Mortalidad perinatal:** hasta 75%.
- **Recurrencia en embarazos posteriores:** 5–9%.

Cuanto menor sea el tiempo desde la ruptura a la intervención (<10–15 minutos), mayor la sobrevida materno-fetal.

13. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□

Perlas

1. Triada clásica: **dolor súbito + pérdida de contracciones + bradicardia fetal.**

2. **Antecedente de cesárea previa** es el principal factor de riesgo.
3. Diagnóstico **clínico inmediato**: no esperar exámenes.
4. **Tratamiento**: laparotomía urgente.
5. **Reparación uterina** si lesión limitada; **histerectomía** si sangrado masivo o ruptura extensa.
6. Evitar **PVDC** en cicatriz corporal o T.
7. En trabajo de parto con cesárea previa: **monitoreo continuo y bajo umbral para cesárea**.

□

Errores comunes

- Confundir con DPPNI o trabajo de parto doloroso.
- Usar uterotónicos ante sospecha de ruptura (agrava cuadro).
- Esperar ecografía o laboratorio antes de intervenir.
- No revisar historia quirúrgica uterina.
- Intentar parto vaginal en cicatriz corporal previa.

14. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Ruptura uterina**: solución de continuidad completa de la pared uterina.
2. **Causa principal**: cesárea previa, uso inadecuado de uterotónicos o parto obstructivo.
3. **Clínica clásica**: dolor súbito + cese de contracciones + bradicardia fetal.
4. **Diagnóstico clínico** → **laparotomía inmediata**.
5. **Tratamiento**: estabilización, extracción fetal, reparación o histerectomía.
6. **Evitar inducción o PVDC en cicatriz corporal**.

7. **Mortalidad fetal elevada:** hasta 75%, dependiente de rapidez diagnóstica.